

Depresión mayor – Criterios, diagnóstico diferencial, manejo farmacológico y psicoterapéutico

1. Introducción y relevancia clínica

La **depresión mayor** es uno de los trastornos mentales más frecuentes y discapacitantes a nivel mundial.

Según la **OMS (2023)**, afecta a más de **280 millones de personas**, siendo la principal causa de discapacidad global y un factor de riesgo significativo para el **suicidio**.

En Chile, la prevalencia de depresión alcanza alrededor del **17%** en la población general, con mayor afectación en mujeres y personas con bajo nivel socioeconómico.

Es una patología **GES (Garantías Explícitas en Salud)**, lo que garantiza diagnóstico y tratamiento gratuito en el sistema público.

El reconocimiento y manejo adecuados por parte del médico general son esenciales, ya que **la mayoría de los pacientes consulta inicialmente en APS y no refiere espontáneamente ánimo deprimido**, sino síntomas somáticos como fatiga, insomnio o dolores inespecíficos.

- En el **EUNACOM**, este tema es transversal: se evalúa el diagnóstico clínico, la elección del ISRS adecuado, el manejo inicial del riesgo suicida y el seguimiento terapéutico.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La depresión es un **trastorno multifactorial** donde convergen alteraciones **neurobiológicas, genéticas, psicológicas y sociales**.

2.1. Bases neuroquímicas

- **Hipótesis monoaminérgica:**

Disminución de serotonina (5-HT), noradrenalina (NA) y dopamina (DA) en áreas cerebrales reguladoras del ánimo (corteza prefrontal, sistema límbico).

- **Disfunción del eje hipotálamo–hipófisis–adrenal (HHA):**

Hiperactividad del eje → aumento de cortisol plasmático crónico.

- **Neuroplasticidad reducida:**

Menor factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) → atrofia hipocámpal.

2.2. Factores de riesgo

- **Biológicos:** antecedentes familiares, enfermedades crónicas (diabetes, cáncer, ECV).
- **Psicológicos:** baja autoestima, trauma infantil, duelo no resuelto.
- **Sociales:** aislamiento, pobreza, desempleo, violencia de pareja.

□ La combinación de vulnerabilidad biológica y factores estresantes precipita el episodio depresivo.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Criterios diagnósticos (DSM-5 / CIE-10)

Síntomas cardinales (debe haber ≥5 durante ≥2 semanas):

1. Ánimo deprimido la mayor parte del día.
2. Pérdida de interés o placer (anhedonia).
3. Alteraciones del apetito o peso.
4. Insomnio o hipersomnia.
5. Agitación o enlentecimiento psicomotor.
6. Fatiga o pérdida de energía.
7. Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva.
8. Disminución de la concentración o indecisión.
9. Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio.

Condiciones adicionales:

- Causa malestar clínicamente significativo o deterioro funcional.
- No se explica mejor por sustancias, duelo o enfermedades médicas.
- Ausencia de episodios maníacos previos.

3.2. Clasificación de la depresión

Tipo	Características
Episodio depresivo leve	2–3 síntomas principales, funcionalidad conservada
Moderado	4–5 síntomas, alteración laboral/social significativa
Grave	≥6 síntomas, riesgo suicida o ideación persistente
Con síntomas psicóticos	Ideas delirantes congruentes con el ánimo o alucinaciones auditivas
Atípica	Hiperfagia, hipersomnia, reactividad afectiva
Estacional	Recaídas durante meses específicos (invierno)
Pós-parto	Dentro de las 6 primeras semanas tras parto

3.3. Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Características diferenciales

Trastorno bipolar	Episodios previos de hipomanía o manía
Trastorno de adaptación	Relación directa con evento estresante, duración <6 meses
Duelo normal	Tristeza proporcional, preserva autoestima, sin ideación suicida persistente
Demencia	Deterioro cognitivo progresivo, inicio insidioso
Hipotiroidismo	Fatiga, aumento de peso, piel seca, TSH elevada
☐ En EUNACOM, diferenciar entre duelo normal y depresión mayor es una pregunta frecuente.	

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Aunque el diagnóstico es **clínico**, los exámenes buscan **descartar causas orgánicas** o condiciones que exacerben la depresión:

Examen	Objetivo
Hemograma, VHS	Anemia, infección crónica
TSH	Hipotiroidismo
Glicemia, perfil lipídico	Evaluar comorbilidades
Función hepática y renal	Uso seguro de psicofármacos

PHQ-9 o Escala de Hamilton Cuantificar severidad

☐ **PHQ-9:** instrumento validado en Chile por MINSAL.

Puntuación ≥ 10 sugiere depresión clínica; ≥ 20 indica depresión grave.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile 2023)

El manejo debe ser **integral y escalonado**, combinando **farmacoterapia, psicoterapia y apoyo psicosocial**.

5.1. Objetivos

- Remisión de síntomas y restauración funcional.
 - Prevención de recaídas y suicidio.
 - Reintegración social y laboral.
-

5.2. Tratamiento farmacológico

Primera línea: ISRS

- **Sertralina:** 50 mg/día (máx. 200 mg).
- **Fluoxetina:** 20 mg/día (máx. 60 mg).
- **Escitalopram:** 10 mg/día (máx. 20 mg).
- **Citalopram o paroxetina** como alternativas.

Duración:

- Continuar por **al menos 6–12 meses** tras remisión.
- Si ≥ 2 episodios previos, considerar tratamiento indefinido.

Respuesta esperada:

- Inicio: 2–4 semanas.

- Evaluar cambio o ajuste si no hay mejoría a las 6–8 semanas.

Segunda línea

- IRSN (venlafaxina, duloxetina).
- Mirtazapina (útil si insomnio o pérdida de peso).
- Bupropión (si fatiga o disfunción sexual).

□ Evitar tricíclicos (amitriptilina) en APS por riesgo de toxicidad y arritmias en sobredosis.

5.3. Psicoterapia

- **Terapia cognitivo-conductual (TCC):** reestructuración de pensamientos negativos, evidencia robusta.
 - **Terapia interpersonal:** mejora habilidades relacionales.
 - **Psicoeducación familiar:** clave en prevención de recaídas.
 - **Terapia combinada (ISRS + TCC):** superior a monoterapia en casos moderados-graves.
-

5.4. Manejo del riesgo suicida

- Evaluar en **toda consulta**.
 - Derivar urgente si hay ideación activa o plan suicida.
 - Hospitalizar si riesgo alto o intento reciente.
 - Retirar medios letales del hogar.
 - Control semanal en fase aguda.
-

5.5. Medidas complementarias

- Actividad física regular (≥ 150 min/semana).
 - Higiene del sueño.
 - Evitar alcohol y drogas.
 - Apoyo social y laboral.
 - Programas MINSAL: **GES Depresión y Estrategia Nacional de Salud Mental**.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones

- Suicidio o intento autolítico.
- Crónica o recurrente (50% recaídas en 2 años).
- Aislamiento social, pérdida laboral.
- Efectos secundarios por psicofármacos.
- Deterioro cognitivo (“pseudodemencia depresiva”).

Pronóstico

- **Buena respuesta:** 70–80% con tratamiento adecuado.
 - **Mal pronóstico:** inicio precoz, comorbilidad psiquiátrica, pobre adherencia.
 - **Prevención de recaídas:** psicoterapia de mantenimiento y seguimiento regular.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. Diagnóstico = ≥ 5 síntomas durante ≥ 2 semanas, con ánimo deprimido o anhedonia.
 2. Los **ISRS son primera línea**, seguros y eficaces.
 3. La respuesta clínica se evalúa **a las 6–8 semanas**.
 4. Siempre **preguntar por ideación suicida** (no aumenta el riesgo).
 5. **Terapia combinada (ISRS + TCC)** tiene mejor eficacia.
 6. Continuar ISRS **mínimo 6 meses después de la remisión**.
 7. El **duelo normal** no implica ideación suicida persistente ni culpa excesiva.
-



Errores comunes

- Suspender el antidepresivo antes de tiempo (“efecto rebote”).
 - No diferenciar depresión de **bipolaridad** (evitar ISRS en manía).
 - No pesquisar causas orgánicas (TSH, anemia).
 - No evaluar ni registrar riesgo suicida.
 - Usar benzodiacepinas como tratamiento principal.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **depresión mayor** es un trastorno del ánimo frecuente, discapacitante y GES en Chile.
2. El diagnóstico se basa en **≥ 5 síntomas durante ≥ 2 semanas**, con ánimo deprimido o anhedonia.
3. El tratamiento combina **ISRS (primera línea)** y **psicoterapia cognitivo-conductual**.
4. Evaluar siempre **riesgo suicida** y garantizar red de apoyo.

5. Mantener el tratamiento **6–12 meses tras la remisión**.
6. Derivar si depresión grave, psicótica o resistente.
7. La **detección precoz y seguimiento en APS** mejoran el pronóstico y reducen mortalidad.